

Concours



جهة مراكش أسفي
Région Marrakech Safi

Avec Justification



[Lien Page Instagram](#)

PRÉPA
CONCOURS
MSPS



OFFRE DE PRÉPARATION AU CONCOURS COMMUN DE
RECRUTEMENT- INSCRIPTION OUVERTE

1. Quelle est la principale préoccupation de la démographie ?

- A. L'étude des comportements individuels
- B. L'éducation des populations à besoins spécifiques
- C. L'étude des populations humaines
- D. La recherche médicale

2. Quel aspect de la population les démographes étudient-ils principalement ?

- A. La qualité de vie
- B. La dimension, la structure et l'évolution
- C. Les politiques publiques
- D. Les préférences culturelles

3. La démographie envisage principalement les caractéristiques des populations sous quel angle ?

- A. Qualitatif
- B. Psychologique
- C. Historique
- D. Quantitatif

4. Que désigne le terme "migration spatiale" ?

- A. Le déplacement à l'intérieur d'un même territoire
- B. Le déplacement entre deux espaces économiques
- C. Le déplacement simultané entre deux lieux : lieu d'origine et lieu de destination
- D. Le déplacement temporaire

5. Comment définit-on la migration nette ?

- A. Le nombre total de déplacements effectués pendant une période donnée
- B. La différence entre les migrations entrantes et sortantes
- C. L'ensemble des déplacements internes de santé
- D. La mobilité temporaire

6. Quelle est la caractéristique principale de la migration interne ?

- A. Le lieu d'origine et le lieu de destination se trouvent dans des pays différents
- B. La migration interne est limitée aux changements de résidence à l'intérieur d'un même territoire
- C. La migration interne concerne uniquement les déplacements internationaux
- D. Une migration définitive d'un lieu à un autre

7. La migration interne inclut :

- A. Les déplacements quotidiens des travailleurs entre le lieu de travail et le lieu de

résidence

B. Les migrations de courte durée vers une autre région pendant les vacances

C. La migration interne est limitée aux changements de résidence à l'intérieur d'un même lieu

D. Une migration saisonnière pour des événements spéciaux

8. Quelle est la formule pour calculer le Taux de mortalité infantile (TMI) ?

A. $TMI = \left(\frac{\text{Nombre de décès d'enfants de moins d'un an durant une année donnée}}{\text{Total des naissances vivantes durant cette année}} \right) \times 100$

B. $TMI = \left(\frac{\text{Nombre de décès d'enfants de moins d'un an durant une année donnée}}{\text{Total des naissances vivantes durant cette année}} \right) \times 1000$

C. $TMI = \left(\frac{\text{Nombre de décès d'enfants de moins d'un an durant une année donnée} + \text{Total des naissances vivantes durant cette année}}{\text{Total des naissances vivantes durant cette année}} \right) / 1000$

D. $TMI = \left(\frac{\text{Total des naissances vivantes durant cette année} - \text{Nombre de décès d'enfants de moins d'un an durant une année donnée}}{\text{Total des naissances vivantes durant cette année}} \right) / 1000$

9. Comment l'OMS définit-elle la santé publique selon la définition de 1952 ?

A. Comme la science et l'art de traiter les maladies à un niveau individuel

B. Comme la Science et l'art de prévenir les maladies, prolonger la vie, et améliorer la santé physique et mentale à un niveau individuel et collectif

C. Comme la gestion des établissements de santé et des services médicaux

D. Comme la recherche et le développement de nouveaux médicaments

10. Quel est un des objectifs de la santé publique selon la définition de l'OMS ?

A. Augmenter les coûts des soins de santé pour la population

B. Réduire le nombre de professionnels médicaux nécessaires

C. Prolonger la vie et améliorer la santé physique et mentale

D. Promouvoir exclusivement la recherche sur les médicaments

11. Comment la santé publique aborde-t-elle généralement les problèmes de santé ?

A. En traitant uniquement au niveau individuel

B. En se concentrant uniquement sur les traitements médicaux

C. En mobilisant l'ensemble de la population pour traiter les problèmes de santé

D. En privilégiant uniquement les soins intensifs

12. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), comment est-ce que la santé est décrite ?

A. Comme l'absence de maladie ou d'infirmité

B. Comme un état de complet bien-être physique, mental et social

- C. Comme la capacité à mener une vie active sans limitation
- D. Comme la possibilité de se soigner dans les établissements de santé

13. Selon la définition de l'OMS, qu'est-ce qui caractérise une communauté ?

- A. Des individus partageant les mêmes centres d'intérêt
- B. Un groupe de personnes vivant dans la même région géographique définie, partageant une culture, des valeurs et ayant des interactions sociales
- C. Des professionnels de santé regroupés dans une organisation
- D. Un ensemble de patients suivant un traitement médical similaire

14. Selon l'OMS, que désignent les Déterminants Sociaux de la Santé (DSS) ?

- A. Les infrastructures mises en place pour les objectifs professionnels communs
- B. Les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que le système mis en place pour faire face à la maladie
- C. Les politiques de santé publique au niveau national
- D. Les médicaments disponibles sur le marché

15. Quels sont les différents niveaux de participation de la communauté dans les programmes, selon le degré d'implication ?

- A. Participation aux avantages des programmes
- B. Participation aux activités des programmes
- C. Participation à l'exécution des programmes
- D. Participation à la planification des programmes

16. L'apparition dans une collectivité humaine d'une maladie dont la fréquence est clairement en excès par rapport à la fréquence attendue :

- A. Épidémie
- B. Endémie
- C. Pandémie
- D. Cas sporadiques

17. La Pandémie est un phénomène de masse

- A. Limité dans le temps et dans l'espace
- B. Limité dans le temps illimité dans l'espace
- C. Limité dans le temps et dans l'espace avec fréquence basse
- D. Illimité dans le temps, limité dans l'espace

18. La démarche épidémiologique consiste à :

- A. Mesurer la fréquence d'un phénomène de santé, tel qu'une maladie, d'en faire la distribution selon les caractéristiques de personne, de lieu et de temps

- B. Émettre des hypothèses sur les déterminants de la fréquence d'un phénomène
- C. Une fois les hypothèses vérifiées, des actions appropriées seront menées pour contrôler voire éliminer le phénomène en question
- D. Évaluer l'impact des actions implantées sur la fréquence du phénomène de santé

19. Les types d'enquêtes utilisées dans les études épidémiologiques analytiques sont :

- A. Enquêtes cas-témoins
- B. Étude de cohorte prospective (enquête exposés/non exposés)
- C. Enquête analytique transversale
- D. Enquête de consommation

20. La participation communautaire est :

- A. Un processus par lequel les individus et les familles, prenant en charge leur propre santé et leur propre bien-être, le développent au sein de la communauté.
- B. La capacité des individus de concourir à leur propre développement comme à celui de communauté.
- C. Un processus au cours duquel les professionnels de santé planifient uniquement des actions de santé.
- D. La mise en œuvre par la population dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de santé.

21. Les clés de réussite de l'action communautaire sont :

- A. La confidentialité
- B. La coordination
- C. Volontariat
- D. Partenariat et engagement des parties prenantes

22. La chaîne de transmission de l'infection est composée de :

- A. L'agent infectieux,
- B. Le réservoir,
- C. La porte de sortie, le mode, et la porte d'entrée
- D. L'hôte réceptif.

23. Le mode de transmission indirect, c'est-à-dire :

- A. Lorsque le pathogène est transmis par contact étroit entre un sujet infecté et un hôte réceptif
- B. Lorsque la transmission s'effectue par l'intermédiaire d'un vecteur (insecte, animal)
- C. Lorsque la transmission s'effectue par l'intermédiaire d'un « véhicule » comme l'eau

ou un aliment (cas du choléra, de l'hépatite, de la poliomyélite, etc.)

D. Le mode de transmission des maladies suivantes (tuberculose, sida, syphilis)

24. Les vecteurs de transmission du paludisme sont :

A. Les phlébotomes femelles

B. Les anophèles femelles

C. Les phlébotomes mâles

D. Les puces

25. Quelle est la particularité essentielle de la Communauté selon l'OMS ?

A. Une population aux niveaux économiques variés, capable de s'engager dans des projets communautaires

B. Un ensemble de personnes engagées dans des activités de santé dans une zone géographique définie

C. Un groupe partageant des valeurs et des normes dans une zone géographique définie

D. Un groupe de citoyens de la même zone géographique

26. Qu'est-ce qui caractérise une intervention Santé/Environnement à base communautaire par rapport à d'autres initiatives de santé ?

A. Elle repose sur une analyse des besoins locaux et une implication active de la communauté.

B. Elle bénéficie d'un financement mixte, incluant des partenariats publics et privés.

C. Elle vise à prévenir à la fois les maladies transmissibles et non transmissibles.

D. Elle est adaptée aux contextes urbains et ruraux selon les besoins locaux.

27. Pourquoi l'approche fondée sur le genre est-elle intégrée dans les interventions de santé communautaire ?

A. Pour garantir que les besoins spécifiques des différents genres soient pris en compte dans les interventions.

B. Pour promouvoir les droits des femmes dans les milieux urbains et ruraux.

C. Pour assurer une distribution équitable des ressources en fonction des besoins de genre.

D. Pour améliorer l'égalité de participation entre les hommes et les femmes dans les prises de décision.

28. Quel type de données est crucial lors de la phase de diagnostic dans un programme d'intervention santé communautaire ?

A. Données sur les déterminants sociaux de la santé

- B. Données issues des systèmes de soins et services communautaires
- C. Données sur les dynamiques de pouvoir et les relations communautaires
- D. Données sur les besoins sanitaires exprimés et ressentis par la communauté

29. Quel est l'impact attendu de la participation communautaire dans un programme santé/environnement ?

- A. Une plus grande résilience face aux maladies
- B. Une meilleure équité dans l'accès aux soins pour les populations vulnérables
- C. Une responsabilisation accrue des populations locales pour une meilleure distribution des soins
- D. Amélioration des connaissances des populations locales et des interventions localisées

30. Quelle est la définition la plus appropriée de l'éthique ?

- A. L'ensemble des règles écrites qui régissent la conduite humaine dans la société.
- B. L'ensemble des règles de conduite spécifiques à une profession.
- C. L'ensemble de principes permettant de distinguer le juste de l'injuste.
- D. Une réflexion argumentée visant à promouvoir le bien-agir.

31. Que fournit l'éthique dans le contexte professionnel ?

- A. Des solutions toutes faites aux problèmes.
- B. Un éclairage utile pour le raisonnement et les décisions.
- C. Un ensemble strict de règles à suivre.
- D. Des réponses définitives à toutes les questions morales.

32. Qu'est-ce qu'une question éthique ?

- A. Une interrogation dont la réponse est définie par la science.
- B. Un questionnement sur l'adéquation des soins à prodiguer.
- C. Une interrogation dont la réponse n'est pas dans le registre « scientifique ».
- D. Une décision facile à prendre en contexte médical.

33. Comment aborde-t-on une situation éthique en santé communautaire ?

- A. En réfléchissant et en décidant seul.
- B. En discutant uniquement avec les agents communautaires.
- C. En réfléchissant en groupe (importance de la pluridisciplinarité).
- D. En suivant strictement les protocoles établis.

34. Qu'est-ce qu'un dilemme éthique ?

- A. Une situation causant de la détresse morale.
- B. Une circonstance où deux valeurs éthiques conflictuelles doivent être pesées.

- C. Une confusion entre choix professionnels et personnels.
- D. Une simple fatigue émotionnelle due au stress.

35. Quelles qualités caractérisent un infirmier leader ?

- A. Capacité à influencer ses pairs.
- B. Compétences en jugement professionnel et création de relations.
- C. Priorisation des protocoles et des objectifs administratifs.
- D. Décisions basées uniquement sur les objectifs administratifs.

36. Quel est l'objectif principal du fonds communautaire ?

- A. Assurer le financement exclusif des projets de développement pour exécuter des prestations sociales.
- B. Gérer les ressources humaines, matérielles ou financières des services d'intérêt collectif.
- C. Contribuer à l'autonomie des associations locales dans leur collaboration.
- D. Éliminer la dépendance aux ressources des associations de petite envergure.

37. Quels sont les avantages d'une action communautaire dans un partenariat ?

- A. Augmentation des ressources humaines.
- B. Partage des informations, des finances et des ressources.
- C. Dépendance accrue aux institutions financières uniquement.
- D. Limitation des interventions aux sources d'information uniquement.

38. Quelle est la première étape pour développer un partenariat ?

- A. Identifier les partenaires potentiels.
- B. Identifier les partenaires souhaités du partenariat.
- C. Déterminer les résultats souhaités du partenariat.
- D. Évaluer la situation actuelle.

39. Quelle est la première étape de l'action communautaire ?

- A. Identification et priorisation des problèmes.
- B. Collecte et analyse des données sanitaires et communautaires.
- C. Programmation du projet.
- D. Suivi et évaluation.

40. Quelle étape vient directement après la mise en œuvre du projet ?

- A. Suivi et évaluation.
- B. Collecte et analyse des données sanitaires et communautaires.
- C. Identification et priorisation des problèmes.
- D. Identification du projet communautaire.

1. Quelle est la principale préoccupation de la démographie ?

- A. L'étude des comportements individuels
- B. L'éducation des populations à besoins spécifiques
- C. L'étude des populations humaines
- D. La recherche médicale

Démographie : Définitions (suite)

- Etude chiffrée des populations humaines.
Dictionnaire démographique de l'ONU
- La démographie est une science ayant pour objet l'étude des populations humaines, et traitant de leur dimension, de leur structure, de leur évolution et de leurs caractères généraux envisagés principalement d'un point de vue quantitatif ». **Démopaedia**

2. Quel aspect de la population les démographes étudient-ils principalement ?

- A. La qualité de vie
- B. La dimension, la structure et l'évolution
- C. Les politiques publiques
- D. Les préférences culturelles

Démographie : Définitions (suite)

- Etude chiffrée des populations humaines. **Dictionnaire démographique de l'ONU**
- La démographie est une science ayant pour objet l'étude des populations humaines, et traitant de leur dimension, de leur structure, de leur évolution et de leurs caractères généraux envisagés principalement d'un point de vue quantitatif ». **Démopaedia**

3. La démographie envisage principalement les caractéristiques des populations sous quel angle ?

- A. Qualitatif
- B. Psychologique
- C. Historique
- D. Quantitatif**

Démographie : Définitions (suite)

- Etude chiffrée des populations humaines. **Dictionnaire démographique de l'ONU**
- La démographie est une science ayant pour objet l'étude des populations humaines, et traitant de leur dimension, de leur structure, de leur évolution et de leurs caractères généraux envisagés principalement d'un point de vue quantitatif ». **Démopaedia**

4. Que désigne le terme "migration spatiale" ?

- A. Le déplacement à l'intérieur d'un même territoire
- B. Le déplacement entre deux espaces économiques
- C. Le déplacement simultané entre deux lieux : lieu d'origine et lieu de destination
- D. Le déplacement temporaire

La migration spatiale décrit un **mouvement géographique et relativement durable d'individus ou de populations d'un lieu de résidence vers un autre**, que ce soit à l'intérieur d'un même pays (migration interne) ou d'un pays à un autre (migration internationale). Ce déplacement, motivé par des raisons diverses (économiques, politiques, personnelles, environnementales), implique une interaction spatiale entre un lieu d'origine et une destination, et peut modifier la perception des espaces et des identités. 

5. Comment définit-on la migration nette ?

- A. Le nombre total de déplacements effectués pendant une période donnée
- B. La différence entre les migrations entrantes et sortantes
- C. L'ensemble des déplacements internes de santé
- D. La mobilité temporaire

Rappelons pour commencer la définition de la migration nette d'une zone : il s'agit de la différence entre le nombre d'immigrations vers cette zone et le nombre des émigrations au départ de cette zone. On travaille dans ce cas sur des événements, les migrations, et non sur des individus, les migrants ou les derniers migrants. Ainsi, les migrations d'individus décédés ultérieurement sont comptées dans cette migration nette, de même que les migrations d'enfants nés au cours de la période considérée. De façon semblable, il faudra tenir compte de chaque migration effectuée par un individu ayant fait des migrations multiples. Mais, dans la mesure où un individu effectue un retour, celui-ci efface le départ lorsqu'on estime la migration nette.



Taux d'accroissement :

Le taux d'accroissement est le taux avec lequel une population augmente (ou diminue) durant une année donnée en raison de l'augmentation naturelle et de la migration nette exprimée en pourcentage de la population de base

*Naissances de l'année t - Décès de l'année +
Migration nette*

*Population moyenne (Population totale au milieu
de l'année t)*

6. Quelle est la caractéristique principale de la migration interne ?

- A. Le lieu d'origine et le lieu de destination se trouvent dans des pays différents
- B. La migration interne est limitée aux changements de résidence à l'intérieur d'un même territoire
- C. La migration interne concerne uniquement les déplacements internationaux
- D. Une migration définitive d'un lieu à un autre

TERME DU GLOSSAIRE

Migration interne

Migration dans laquelle les gens se déplacent à l'intérieur des frontières nationales.

7. La migration interne inclut :

- A. Les déplacements quotidiens des travailleurs entre le lieu de travail et le lieu de résidence
- B. Les migrations de courte durée vers une autre région pendant les vacances
- C. La migration interne est limitée aux changements de résidence à l'intérieur d'un

même lieu

D. Une migration saisonnière pour des événements spéciaux

8. Quelle est la formule pour calculer le Taux de mortalité infantile (TMI) ?

A. $TMI = (\text{Nombre de décès d'enfants de moins d'un an durant une année donnée} / \text{Total des naissances vivantes durant cette année}) \times 100$

B. $TMI = (\text{Nombre de décès d'enfants de moins d'un an durant une année donnée} / \text{Total des naissances vivantes durant cette année}) \times 1000$

C. $TMI = (\text{Nombre de décès d'enfants de moins d'un an durant une année donnée} + \text{Total des naissances vivantes durant cette année}) / 1000$

D. $TMI = (\text{Total des naissances vivantes durant cette année} - \text{Nombre de décès d'enfants de moins d'un an durant une année donnée}) / 1000$

a. Taux de mortalité infantile (TMI)

$$TMI = \frac{\text{Nombre d'enfants décédés avant l'âge de 1 an pendant une année}}{\text{Nombre de naissances vivantes la même année}} \times 1000$$

9. Comment l'OMS définit-elle la santé publique selon la définition de 1952 ?

A. Comme la science et l'art de traiter les maladies à un niveau individuel

B. Comme la Science et l'art de prévenir les maladies, prolonger la vie, et améliorer la santé physique et mentale à un niveau individuel et collectif

C. Comme la gestion des établissements de santé et des services médicaux

D. Comme la recherche et le développement de nouveaux médicaments

Santé publique

L'OMS, en 1952, en donne la définition suivante : La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus. La santé publique est aujourd'hui une discipline autonome qui s'occupe de l'état sanitaire d'une collectivité, de la santé globale des populations sous tous ces aspects : curatif, préventif, éducatif et social. La santé publique peut être aussi considérée comme une institution sociale, une discipline et une pratique.

10. Quel est un des objectifs de la santé publique selon la définition de l'OMS ?

A. Augmenter les coûts des soins de santé pour la population

B. Réduire le nombre de professionnels médicaux nécessaires

C. Prolonger la vie et améliorer la santé physique et mentale

D. Promouvoir exclusivement la recherche sur les médicaments

Santé publique

L'OMS, en 1952, en donne la définition suivante : La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus. La santé publique est aujourd'hui une discipline autonome qui s'occupe de l'état sanitaire d'une collectivité, de la santé globale des populations sous tous ces aspects : curatif, préventif, éducatif et social. La santé publique peut être aussi considérée comme une institution sociale, une discipline et une pratique.

11. Comment la santé publique aborde-t-elle généralement les problèmes de santé ?

A. En traitant uniquement au niveau individuel

B. En se concentrant uniquement sur les traitements médicaux

C. En mobilisant l'ensemble de la population pour traiter les problèmes de santé

D. En privilégiant uniquement les soins intensifs

12. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), comment est-ce que la santé est décrite ?

A. Comme l'absence de maladie ou d'infirmité

B. Comme un état de complet bien-être physique, mental et social

C. Comme la capacité à mener une vie active sans limitation

D. Comme la possibilité de se soigner dans les établissements de santé

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme « *un état de complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité* »¹. La santé est ainsi prise en compte dans sa globalité. Elle est associée à la notion de bien-être.

13. Selon la définition de l'OMS, qu'est-ce qui caractérise une communauté ?

A. Des individus partageant les mêmes centres d'intérêt

B. Un groupe de personnes vivant dans la même région géographique définie, partageant une culture, des valeurs et ayant des interactions sociales

C. Des professionnels de santé regroupés dans une organisation

D. Un ensemble de patients suivant un traitement médical similaire

« La communauté est un groupe d'individus qui vivent ensemble dans des conditions spécifiques d'organisation et de cohésion. Liaison par des caractéristiques géographiques, politiques, économiques, sociales et culturelles communes avec des intérêts et aspirations communes en matière de santé ».

« La communauté est un groupe de personnes qui régissent leur vie ensemble selon des principes partagés et acceptés par chacun et reconnu comme tels par tous, ce qui implique des liens. »

14. Selon l'OMS, que désignent les Déterminants Sociaux de la Santé (DSS) ?

- A. Les infrastructures mises en place pour les objectifs professionnels communs
- B. Les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que le système mis en place pour faire face à la maladie
- C. Les politiques de santé publique au niveau national
- D. Les médicaments disponibles sur le marché

Définition officielle selon l'OMS :

« Les déterminants de la santé sont les facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus ou des populations. » (OMS)

Les déterminants sociaux de la santé sont les conditions dans lesquelles les personnes naissent, grandissent, travaillent, vivent et vieillissent, ainsi que les forces plus larges qui façonnent les conditions de la vie quotidienne. La majeure partie de notre santé est déterminée par ces causes profondes non médicales de mauvaise santé, notamment l'accès limité à une éducation de qualité, à des aliments nutritifs et à un logement et des conditions de travail décentes.

15. Quels sont les différents niveaux de participation de la communauté dans les programmes, selon le degré d'implication ?

- A. Participation aux avantages des programmes
- B. Participation aux activités des programmes
- C. Participation à l'exécution des programmes
- D. Participation à la planification des programmes

a) Participation aux avantages des programmes :

Les membres de la communauté bénéficient de services divers mis à leur disposition par différents organismes et institutions. Bien souvent, le bénéficiaire se contente d'aller chercher ce service. A ce niveau, la participation communautaire peut être considérée comme passive.

b) Participation aux activités des programmes :

La communauté bénéficie des avantages et participe aux activités des programmes et ce, en mettant à la disposition des locaux, de la main d'œuvre et/ou de l'argent.

Dans ce cas, les membres de la communauté peuvent assurer certains services simples et la participation est plus active.

c) Participation à l'exécution des programmes :

La communauté bénéficie des avantages et participe aux activités. Elle peut aussi participer au choix de l'emplacement d'un dispensaire et même gérer le système d'achat des médicaments.

Les planificateurs fixent les objectifs à atteindre et identifient les activités à entreprendre, notamment celles que la communauté peut prendre en charge. Cette forme de participation est davantage active, et elle ajoute une dimension de partenariat, de partage de certaines tâches avec les professionnels de santé.

d) Participation à la surveillance et à l'évaluation de ces programmes :

La communauté bénéficie des avantages, participe aux activités et à leur exécution. Certains membres de la communauté peuvent participer au suivi et à l'évaluation de ces programmes. Ils ont aussi la possibilité de modifier les objectifs mais sans les déterminer. Dans certains cas, les membres de la communauté réalisent des enquêtes au sein de leur collectivité, analysent les résultats et ce, en collaboration avec les équipes sanitaires locales, ce qui est la preuve d'une démarche de partenariat plus avancée.

e) Participation à la planification des programmes :

La communauté bénéficie des avantages, participe aux activités, à l'exécution, à la surveillance, à l'évaluation et à la planification des programmes de santé.

A cet effet, certains membres de la communauté peuvent participer aux choix et à la gestion des programmes dont ils assurent, en partie ou en totalité, la responsabilité.

Là, nous sommes en présence d'une démarche de partenariat qui marque toutes les étapes d'une action de santé initiée par le système.

La participation comme processus, est partie intégrante de l'approche communautaire, laquelle approche se singularise par les rapports de la communauté avec les autres intervenants, notamment le système de santé.

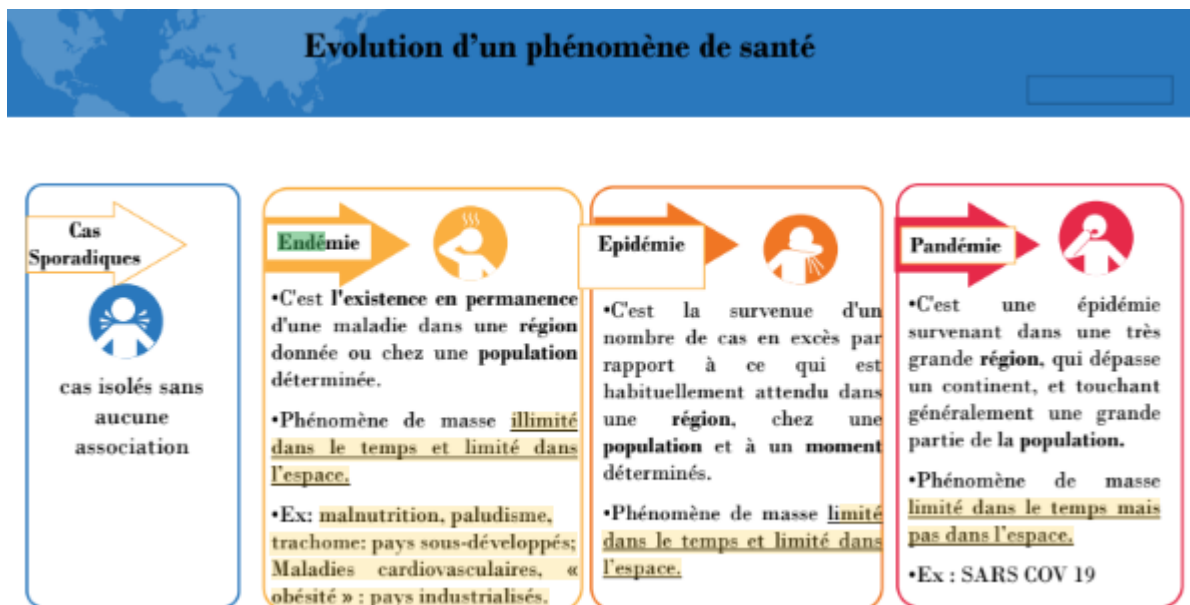
16. L'apparition dans une collectivité humaine d'une maladie dont la fréquence est clairement en excès par rapport à la fréquence attendue :

A. Épidémie

B. Endémie

C. Pandémie

D. Cas sporadiques



17. La Pandémie est un phénomène de masse

A. Limité dans le temps et dans l'espace

B. Limité dans le temps illimité dans l'espace

C. Limité dans le temps et dans l'espace avec fréquence basse

D. Illimité dans le temps, limité dans l'espace

Type	Temps	Espace
Epidémie	Limité	Limité
Endémie	Illimité	Limité
Pandémie	Limité	Illimité

18. La démarche épidémiologique consiste à :

A. Mesurer la fréquence d'un phénomène de santé, tel qu'une maladie, d'en faire la distribution selon les caractéristiques de personne, de lieu et de temps

B. Émettre des hypothèses sur les déterminants de la fréquence d'un phénomène

C. Une fois les hypothèses vérifiées, des actions appropriées seront menées pour contrôler voire éliminer le phénomène en question

D. Évaluer l'impact des actions implantées sur la fréquence du phénomène de santé

LA DEMARCHE EPIDEMIOLOGIQUE

Trois notions fondamentales, essentielles dans la démarche épidémiologique :

La fréquence : Quantification de la survenue ou de l'existence du phénomène

Distribution : Elle permet de répondre à trois questions capitales au cours du raisonnement épidémiologique

- ❖ **QUI** fait la maladie ? (PERSONNE)
- ❖ **OU** survient la maladie ? (LIEU)
- ❖ **QUAND** survient la maladie ? (TEMPS)

Les Déterminants : Causes et facteurs de risque ou de protection En comparant les fréquences selon les caractéristiques de distribution de la maladie on est amené à répondre à une quatrième question : Pourquoi il y a cette distribution de la maladie ?

Pour cela, on émet des hypothèses sur les facteurs possibles qui déterminent la répartition de la maladie (facteurs de risque ou de protection). Une fois l'hypothèse formulée on doit la tester.

Ainsi le processus du raisonnement épidémiologique commence par la suspicion du rôle possible joué par un facteur particulier dans la survenue ou l'existence de la maladie, ce qui conduit à la formulation d'une hypothèse. Cette hypothèse est testée par des études épidémiologiques.

La collecte et l'analyse des données au cours d'une étude épidémiologique conduit à déterminer s'il existe une association statistique entre la maladie et le facteur en question. Une fois l'association déterminée, il faut évaluer sa validité en éliminant certaines éventualités possibles.

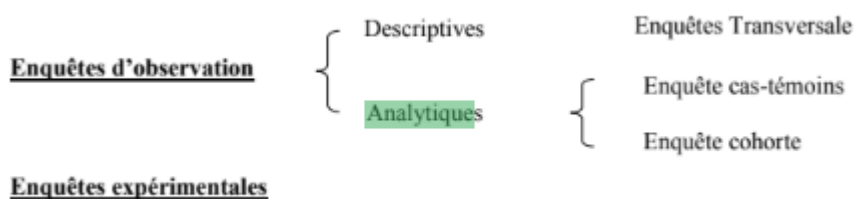
19. Les types d'enquêtes utilisées dans les études épidémiologiques analytiques sont:

A. Enquêtes cas-témoins

B. Étude de cohorte prospective (enquête exposés/non exposés)

C. Enquête analytique transversale

D. Enquête de consommation



20. La participation communautaire est :

A. Un processus par lequel les individus et les familles, prenant en charge leur propre santé et leur propre bien-être, le développent au sein de la communauté.

B. La capacité des individus de concourir à leur propre développement comme à celui de communauté.

C. Un processus au cours duquel les professionnels de santé planifient uniquement des

actions de santé.

D. La mise en œuvre par la population dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de santé.

7. La Participation Communautaire

Selon RIFKIN et al, (1988), la participation communautaire est définie comme étant «un processus social où des groupes définis qui partagent les mêmes besoins et qui vivent dans une région géographique circonscrite, poursuivent activement l'identification de leurs besoins, prennent des décisions et établissent des mécanismes pour répondre à leurs besoins». Il existe cinq niveaux de participation selon le degré d'implication de la communauté :

21. Les clés de réussite de l'action communautaire sont :

A. La confidentialité

B. La coordination

C. Volontariat

D. Partenariat et engagement des parties prenantes

2. Clés de réussite de l'action communautaire

a) Leadership

b) Volontariat

c) Partenariat et engagement des parties prenantes

d) Accompagnement des équipes de projet

e) Communication, plaidoyer et mobilisation sociale

22. La chaîne de transmission de l'infection est composée de :

A. L'agent infectieux,

B. Le réservoir,

C. La porte de sortie, le mode, et la porte d'entrée

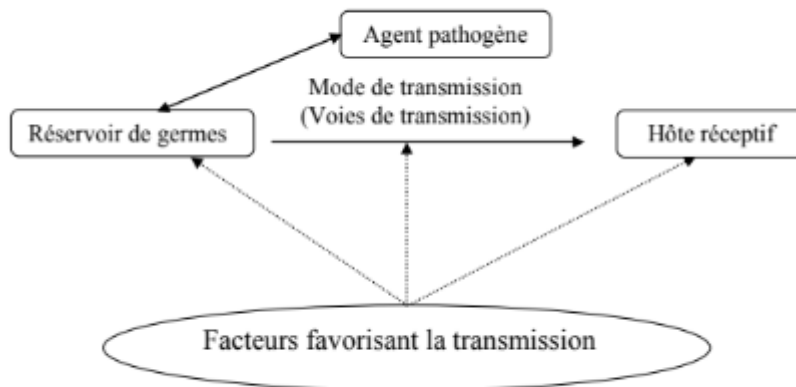
D. L'hôte réceptif.

LA CHAÎNE DE TRANSMISSION

Les agents de transmission de germes : Toute chaîne épidémiologique comprend

- ❖ Un élément qui circule sur la chaîne c'est l'agent pathogène
- ❖ Un élément qui permet la conservation de cet agent, c'est le réservoir de virus.
- ❖ Un agent de transmission qui permet le passage de l'agent pathogène du réservoir de virus, à un sujet sain, c'est le vecteur ou hôte intermédiaire
- ❖ Un sujet sain susceptible de contracter la maladie c'est l'hôte réceptif.

Schéma de la chaîne de transmission



L'intérêt de connaître la chaîne de transmission c'est de pouvoir Interrompre la transmission

La chaîne de transmission se compose des éléments suivants :

1. Un agent pathogène (étiologique)
2. Un réservoir du germe
3. Un mode de transmission
4. Un terrain réceptif (l'hôte réceptif)
(Parfois un hôte intermédiaire)

23. Le mode de transmission indirect, c'est-à-dire :

A. Lorsque le pathogène est transmis par contact étroit entre un sujet infecté et un hôte réceptif

B. Lorsque la transmission s'effectue par l'intermédiaire d'un vecteur (insecte, animal)

C. Lorsque la transmission s'effectue par l'intermédiaire d'un « véhicule » comme l'eau ou un aliment (cas du choléra, de l'hépatite, de la poliomyélite, etc.)

D. Le mode de transmission des maladies suivantes (tuberculose, sida, syphilis)

2. Transmission indirecte

La transmission indirecte peut se faire par l'intermédiaire d'un véhicule, d'un vecteur ou de l'air.

- ✓ La transmission par un véhicule : par des aliments, des vêtements, la literie et les ustensiles de cuisine.
- ✓ La transmission vectorielle : par un insecte ou un animal
- ✓ La transmission aérienne sur une longue distance se produit lorsqu'il y a dissémination de très fines gouttelettes jusqu'à une porte d'entrée, en général les voies respiratoires.

Il se produit une élimination de l'agent pathogène selon des voies diverses :

Voie respiratoire (rougeole)

Voie digestive (typhoïde)

Voie urinaire (leptospirose)

Voie cutanéomuqueuse (IST)...

NB : *Maladie à chaîne fermée : Le germe ne peut être évacué à l'extérieur que par l'intermédiaire d'un :*

Vecteur vivant exemple :

Paludisme (anophèle)

Peste (puce des rats)

Leishmaniose (phlébotome)

24. Les vecteurs de transmission du paludisme sont :

A. Les phlébotomes femelles

B. Les anophèles femelles

C. Les phlébotomes mâles

D. Les puces

Accueil / insectes & maladies / Le moustique anophèle...

LES INSECTES

LE MOUSTIQUE ANOPHÈLE



Parmi les 3 500 espèces de moustiques existantes, on compte environ 430 espèces du genre Anophèle, présentes sur les 5 continents. Très redouté, le moustique anophèle est le moustique capable de transmettre le paludisme.



25. Quelle est la particularité essentielle de la Communauté selon l'OMS ?

A. Une population aux niveaux économiques variés, capable de s'engager dans des projets communautaires

B. Un ensemble de personnes engagées dans des activités de santé dans une zone géographique définie

C. Un groupe partageant des valeurs et des normes dans une zone géographique

définie

D. Un groupe de citoyens de la même zone géographique

26. Qu'est-ce qui caractérise une intervention Santé/Environnement à base communautaire par rapport à d'autres initiatives de santé ?

A. Elle repose sur une analyse des besoins locaux et une implication active de la communauté.

B. Elle bénéficie d'un financement mixte, incluant des partenariats publics et privés.

C. Elle vise à prévenir à la fois les maladies transmissibles et non transmissibles.

D. Elle est adaptée aux contextes urbains et ruraux selon les besoins locaux.

27. Pourquoi l'approche fondée sur le genre est-elle intégrée dans les interventions de santé communautaire ?

A. Pour garantir que les besoins spécifiques des différents genres soient pris en compte dans les interventions.

B. Pour promouvoir les droits des femmes dans les milieux urbains et ruraux.

C. Pour assurer une distribution équitable des ressources en fonction des besoins de genre.

D. Pour améliorer l'égalité de participation entre les hommes et les femmes dans les prises de décision.

28. Quel type de données est crucial lors de la phase de diagnostic dans un programme d'intervention santé communautaire ?

A. Données sur les déterminants sociaux de la santé

B. Données issues des systèmes de soins et services communautaires

C. Données sur les dynamiques de pouvoir et les relations communautaires

D. Données sur les besoins sanitaires exprimés et ressentis par la communauté

29. Quel est l'impact attendu de la participation communautaire dans un programme santé/environnement ?

A. Une plus grande résilience face aux maladies

B. Une meilleure équité dans l'accès aux soins pour les populations vulnérables

C. Une responsabilisation accrue des populations locales pour une meilleure distribution des soins

D. Amélioration des connaissances des populations locales et des interventions localisées

30. Quelle est la définition la plus appropriée de l'éthique ?

A. L'ensemble des règles écrites qui régissent la conduite humaine dans la société.

- B. L'ensemble des règles de conduite spécifiques à une profession.
- C. L'ensemble de principes permettant de distinguer le juste de l'injuste.
- D. Une réflexion argumentée visant à promouvoir le bien-agir.

31. Que fournit l'éthique dans le contexte professionnel ?

- A. Des solutions toutes faites aux problèmes.
- B. Un éclairage utile pour le raisonnement et les décisions.
- C. Un ensemble strict de règles à suivre.
- D. Des réponses définitives à toutes les questions morales.

32. Qu'est-ce qu'une question éthique ?

- A. Une interrogation dont la réponse est définie par la science.
- B. Un questionnement sur l'adéquation des soins à prodiguer.
- C. Une interrogation dont la réponse n'est pas dans le registre « scientifique ».
- D. Une décision facile à prendre en contexte médical.

33. Comment aborde-t-on une situation éthique en santé communautaire ?

- A. En réfléchissant et en décidant seul.
- B. En discutant uniquement avec les agents communautaires.
- C. En réfléchissant en groupe (importance de la pluridisciplinarité).
- D. En suivant strictement les protocoles établis.

34. Qu'est-ce qu'un dilemme éthique ?

- A. Une situation causant de la détresse morale.
- B. Une circonstance où deux valeurs éthiques conflictuelles doivent être pesées.
- C. Une confusion entre choix professionnels et personnels.
- D. Une simple fatigue émotionnelle due au stress.

35. Quelles qualités caractérisent un infirmier leader ?

- A. Capacité à influencer ses pairs.
- B. Compétences en jugement professionnel et création de relations.
- C. Priorisation des protocoles et des objectifs administratifs.
- D. Décisions basées uniquement sur les objectifs administratifs.

36. Quel est l'objectif principal du fonds communautaire ?

- A. Assurer le financement exclusif des projets de développement pour exécuter des prestations sociales.
- B. Gérer les ressources humaines, matérielles ou financières des services d'intérêt collectif.

- C. Contribuer à l'autonomie des associations locales dans leur collaboration.
- D. Éliminer la dépendance aux ressources des associations de petite envergure.

37. Quels sont les avantages d'une action communautaire dans un partenariat ?

- A. Augmentation des ressources humaines.
- B. Partage des informations, des finances et des ressources.
- C. Dépendance accrue aux institutions financières uniquement.
- D. Limitation des interventions aux sources d'information uniquement.

38. Quelle est la première étape pour développer un partenariat ?

- A. Identifier les partenaires potentiels.
- B. Identifier les partenaires souhaités du partenariat.
- C. Déterminer les résultats souhaités du partenariat.
- D. Évaluer la situation actuelle.

39. Quelle est la première étape de l'action communautaire ?

- A. Identification et priorisation des problèmes.
- B. Collecte et analyse des données sanitaires et communautaires.
- C. Programmation du projet.
- D. Suivi et évaluation.

40. Quelle étape vient directement après la mise en œuvre du projet ?

- A. Suivi et évaluation.
- B. Collecte et analyse des données sanitaires et communautaires.
- C. Identification et priorisation des problèmes.
- D. Identification du projet communautaire.